PFE - Pleito de Financiamento Externo
Parceria Publico-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Proponente: Estado de Mato Grosso do Sul
Processo SEI: 03101.001947/2025-54
Código do pleito: 3059847170/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 80.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 08
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 09
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 10
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 10
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 11
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 12
1. 5. Componentes 13
1. 5. 1. Informações do 1° componente 13
1. 6. Beneficiários 14
1. 7. Anexos 14
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 15
2. 1. Áreas estratégicas 15
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 18
3. 1. 3. Estrutura Operacional 18
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 19
3. 2. Operacionalização e Manutenção 19
3. 3. Planejamento Estratégico 19
3. 4. Anexos 19
4. RISCOS 21
4. 1. Informações do 1° risco 21
4. 2. Informações do 2° risco 21
4. 3. Informações do 3° risco 21
4. 4. Informações do 4° risco 21
4. 5. Anexos 22
5. FINANCIAMENTO 23
5. 1. Condições Financeiras da Operação 23
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 23
5. 2. Cronograma de Desembolso 26
5. 3. Contragarantias 27

5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 27
6. ETAPAS REALIZADAS 28
6. 1. Etapas realizadas 28
6. 2. Anexos 28
7. Baixar todos os anexos 30
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Parceria Publico-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Sigla: PPP HRMS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de Mato Grosso do Sul

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma área territorial de 357.142,082 km² e faz fronteiras internacionais com as Repúblicas do Paraguai e da Bolívia na sua porção sul e sudoeste, onde é banhado pela bacia do Rio Paraguai. Na divisa leste e norte/nordeste é banhado pela bacia do Rio Paraná e seus afluentes, fazendo divisa com cinco estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

A sua organização político-administrativa é constituída por 79 municípios, com seus centros urbanos administrativos e 85 distritos. Dados preliminares do Censo IBGE (2022) demonstram que Mato Grosso do Sul possui elevada concentração populacional em poucos municípios, refletindo em grandes vazios demográficos ao longo de seu espaço geográfico, onde 54,34% do seu contingente populacional — aproximadamente 1,5 milhões de pessoas — residem em apenas quatro municípios (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã), todos com mais de 90.000 habitantes.

O Estado possui 2.833.742 habitantes e uma densidade demográfica de 7,72 hab./km². A população sul-mato-grossense corresponde a 1,36% da população brasileira e 17,18% da região Centro-Oeste. Comparado aos números do Censo IBGE (2010), o Estado apresentou uma taxa de crescimento geométrica de 0,99% no período 2010-2022. O rendimento mensal domiciliar per capita é de R$ 1.839,00.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Mato Grosso do Sul, em 2021, foi de 0,742, classificado como "Alto", mas com queda em relação a 2019 (0,777). Os vazios demográficos e econômicos refletem a disparidade de recursos disponíveis nas diversas regiões e nos 79 municípios, que apresentam grau de desenvolvimento heterogêneo. No que se refere à oferta de serviços públicos, como saúde, a racionalização dessa oferta pode funcionar como elemento catalisador do planejamento e desenvolvimento, promovendo novas regionalizações e transformando a dinâmica econômica e a distribuição de renda.

1. 2. 2. Problema:

O Estado do Mato Grosso do Sul avançou bastante nos seus indicadores de saúde nos últimos 10 anos, mas ainda enfrenta desafios no seu perfil epidemiológico. Entre 2018 e 2022, o número de óbitos aumentou 20% (de 16.591 para 20.417), com pico em 2021 devido a COVID-19 (25.033). A principal causa de óbito são as doenças cardiocirculatórias, que tendem a aumentar com o envelhecimento da população.

A razão de mortalidade materna (RMM) registrou aumento significativo em 2021, maior no estado que no país (122,73 versus 107,53), com causas predominantes de hipertensão arterial e hemorragia. A taxa de mortalidade infantil no estado se manteve menor que a média nacional a partir de 2019 (10,68 versus 11,90 em 2021), mas houve aumento no subgrupo pós-neonatal.

A dengue apresentou crescimento expressivo: em 2023, 94,93% dos municípios registraram alta incidência; até a semana epidemiológica 50, foram 46.809 casos prováveis, sendo 40.887 confirmados e 5.922 em investigação.
O governo estadual, com base nos indicadores de desenvolvimento regional (IDR) e no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), mapeou localidades com diferentes perfis de serviços médico-hospitalares públicos, buscando otimizar recursos e melhorar o acesso.

O Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS) é a unidade líder do Sistema Estadual Hospitalar de Alta Complexidade, referência estadual no SUS, com 362 leitos, 45 especialidades e atuação prioritária na Macrorregião de Saúde Central (Campo Grande e entorno), mas também referência para todo o estado. Atende 34 municípios e cerca de 1,5 milhão de pessoas, sendo 90% da região metropolitana de Campo Grande, dos quais 70% dos atendimentos vêm especificamente do município de Campo Grande.

O HRMS enfrenta sérios desafios:

- Infraestrutura obsoleta: problemas no sistema de climatização e elevadores, baixa manutenção predial e equipamentos médicos defasados.

- Superlotação: taxa de ocupação hospitalar de 92,61% (acima do recomendado de 85%) e, no Pronto Atendimento, picos de 233% (setembro de 2024).
- Uso de prontuários físicos: custo anual de R$ 2,38 milhões.

A modernização, incluindo novo edifício e ampliação da capacidade, é urgente para melhorar a infraestrutura, reduzir a superlotação e otimizar custos.

Para essa modernização, o Estado de Mato Grosso do Sul optou pelo modelo de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, regulada pela Lei Federal nº 11.079/2004 para viabilizar os investimentos necessários, com o parceiro privado responsável pela operação do hospital, exceto pelos serviços médicos. A concessão terá a duração de 30 anos. O governo garantirá foco nos serviços assistenciais, ampliação do acesso à saúde e melhoria na qualidade. O projeto visa reformar o hospital atual e construir novas instalações, aumentando a capacidade de 362 para 577 leitos, especialmente nas áreas críticas como pronto-socorro e UTI. A ampliação inclui leitos adicionais para oncologia, UTI neonatal e cuidados paliativos, atendendo à crescente demanda. Ver Anexo para mais detalhes da concessão.

No Brasil, os contratos de PPP na área da saúde têm se expandido, com consenso entre gestores públicos sobre a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços. Na modalidade "Bata Cinza", como será o caso do HRMS, a operação do hospital será transferida para o parceiro privado, exceto os serviços de assistência médico-hospitalar, garantindo benefícios como: foco do Poder Público nos serviços assistenciais; expansão do acesso à saúde; melhoria na qualidade dos serviços; simplificação na contratação de serviços; sinergia entre projetos, construção e operação; antecipação de investimentos; e remuneração conforme os níveis de serviço prestado, com base em indicadores de desempenho.

Um dos desafios do modelo de contratação em PPP é a constituição de estruturas de garantia, cujo propósito central é assegurar o adimplemento das obrigações assumidas pelo poder público, proporcionando segurança jurídica ao projeto e promovendo o alinhamento de incentivos entre as partes envolvidas. Essa exigência está prevista na Lei nº 11.079/2004, que rege as PPPs, e vem sendo amplamente adotada para garantir a segurança jurídica, a previsibilidade, a atratividade e a viabilidade econômica dos projetos.

No Estado de Mato Grosso do Sul, as obrigações de contratos de PPPs são cobertas por mecanismo duplo de garantia, estabelecido pelas Leis Estaduais 5.829/2022 e 5.830/2022 e regulamentado pelo Decreto Estadual 16.021/2022. A vinculação de recursos do FPE e da Lei Complementar Federal nº 176/2020, no limite global de 20% e 100% respectivamente, cobre o pagamento das contraprestações mensais para os parceiros privados. Em paralelo, é constituída uma conta garantia, com os mesmos recursos, para cobertura das obrigações em caso de inadimplemento do Poder Concedente.

O depósito de recursos públicos em contas garantias tem funcionado adequadamente para os atuais contratos de PPPs (Infovia Digital e Usinas Fotovoltaicas), com contraprestações mensais de respectivamente R$ 1 milhão e R$ 3,5 milhões. No entanto, para a PPP do Hospital Regional, cuja contraprestação mensal é prevista em aproximadamente R$ 30 milhões, a manutenção de recursos em conta garantia pode não representar a melhor solução em termos de custo oportunidade na aplicação de recursos em outras políticas públicas.

1. 2. 6. **Solução:**

A operação de crédito de que trata o pleito está direcionada à garantia de pagamento contingente à concessionária em decorrência de eventual concretização de inadimplementos do poder concedente. Caso o Poder Concedente não realize o pagamento para a concessionária, a garantia (pagamento contingente) poderá ser acionada. Como estes riscos estão relacionados diretamente à remuneração, receita e custos da concessionária, a garantia irá conferir maior confiança aos interessados na concessão, aumentando a chance de sucesso e viabilidade de financiamento do projeto.

Para garantir a viabilidade e atratividade do projeto para investidores e financiadores, o BID ofereceu a possibilidade de uma garantia (operação de crédito contingente) para assegurar os compromissos financeiros do Estado no contrato. Essa garantia visa cobrir compromissos públicos assumidos, mitigando riscos de inadimplência por parte do Estado. A operação de garantia do BID oferece o rating de risco AAA para o projeto e tem efeitos positivos para o contrato:

- Reduz o custo de capital do projeto, permitindo ao concessionário acessar financiamento a menores custos, dado que o risco percebido do projeto diminui substancialmente.
- Aumenta a competitividade da licitação, atraindo licitantes que não estariam dispostos a assumir os riscos de pagamento público do governo.
- Aumenta a bancabilidade do projeto, atraindo financiadores (bancos ou compradores de títulos).

Como instituição internacional, o BID assegura o cumprimento das obrigações financeiras e contratuais, mitigando incertezas legais que podem surgir ao longo do projeto. Sua participação impõe padrões rigorosos de governança e transparência, reduzindo o risco de disputas judiciais e protegendo contra alterações unilaterais, criando um ambiente estável para investidores e concessionários, essencial em contratos de longo prazo.

Ressalta-se que a obrigação primária de pagamento permanece com o Poder Concedente, e a garantia do BID somente é acionada se um ou mais pagamentos devidos pelo estado do Mato Grosso do Sul ao parceiro privado não forem realizados.

A operação de crédito contingente, ao tempo que garante segurança à PPP, permite que recursos antes alocados em conta garantia, possam ser redirecionados de forma mais adequada às políticas públicas e finalidades estatais.

Durante o período de preparação da operação de crédito junto ao BID, o mecanismo de Conta Garantia estará disponível e, após a celebração do contrato de empréstimo, o saldo da Conta Garantia será esvaziado e a operação de crédito contingente passará a ser a garantia pública para o contrato de PPP.

1. 2. 10. **Resultado:**

Com base na classificação de risco AAA, a garantia oferecida pelo BID reduz a percepção de risco do projeto, possibilitando acessar o mercado internacional de capitais com custos de financiamento reduzidos e maior competitividade na licitação. Essa garantia representa inovação na estruturação de garantias de projetos de concessão e poderá servir como modelo para projetos semelhantes, desbloqueando investimentos em infraestrutura social no país. Os benefícios da concessão administrativa, com a viabilização do instrumento, serão:

- Investimentos esperados de R$ 954 milhões;
- Ampliação em quase 60% do número de leitos, com aumento de 250% do Pronto-Socorro;
- Aumento de 96% no número de internações;
- Redução do tempo de permanência de 7,1 para 5,3 dias e o aumento da rotatividade de 4 para 5,6 saídas/leito;
- Atendimentos ano: 132,000 (Internação: 30.000, Pronto Socorro: 42.000, Ambulatório: 60.000);
- Eficientização da operação hospitalar, com potencial de ampliar o uso de energia renovável para 20%;
- Tratamento seguro de 438 toneladas de resíduos Classe A por ano, com redução de 146 toneladas encaminhadas a aterros sanitários, promovendo descaracterização dos resíduos infectantes e sua conversão em resíduos comuns;
- Aporte de R$ 9,6 milhões (CAPEX) para a implantação de sistemas de geração de energia renovável. Além disso, estão previstos R$ 510 mil anuais para a execução de iniciativas de Gestão Ambiental ao longo da concessão;
- No campo da inclusão e gênero, o projeto prevê a contratação de 23% de trabalhadores de grupos vulneráveis, impactando 644 pessoas, sendo 221 na fase de investimentos e 423 na operação. Estima-se que 6% do CAPEX e 14% do OPEX serão destinados a esses trabalhadores.

Além disso, a Concessionária deverá manter 40% de mulheres no Conselho de Administração, superando a média nacional de 38%. Também deverá assegurar, no prazo de até 18 meses após a assinatura do Termo de Entrega de Bem Público, que ao menos 20% do quadro de colaboradores seja composto por pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas, e que 3% do quadro seja formado por mulheres transexuais, travestis ou homens transexuais, sempre respeitando as qualificações exigidas e as diretrizes de não discriminação. Estes números consideram apenas os trabalhadores, os usuários do hospital serão considerados no critério Saúde e Segurança.

A participação do BID, com a garantia, reduz o risco percebido pelos investidores, facilitando o acesso ao crédito e atraindo financiadores. Após o período de cobertura da garantia, o contrato garante compromissos claros para manter a operação e sustentabilidade até o final da concessão. O projeto envolve a comunidade local, gera valor econômico e serve como exemplo de desenvolvimento sustentável, promovendo o acesso à saúde, a qualidade de vida e gerando empregos.

1. 3. **Objetivo**

O objetivo geral do projeto é ampliar o acesso da população de Mato Grosso do Sul à saúde pública de qualidade com impacto na redução da mortalidade e aumento da expectativa da população do MS, por meio do aprimoramento do sistema hospitalar via parceria público-privada. (Impacto). O objetivo do financiamento é apoiar o Estado, por meio de uma garantia (operação de crédito contingente), com seus compromissos fiscais assumidos no contrato.

Impactos associados: Redução da mortalidade institucional no HRMS; Redução da taxa de mortalidade na UCO do HRMS; redução da taxa de letalidade nas UTIs do HRMS.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os objetivos específicos são:

- 01: Expandir o número de leitos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul;

Resultados associados: Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS; Aumento do atendimento ano no HRMS; Taxa de ocupação do Pronto Atendimento.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 02: Melhorar a operação hospitalar, com a eficientização de áreas de apoio à assistência clínica, tecnologia e processos sustentáveis;

Resultados associados: aumento da rotatividade de pacientes; Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS; Contribuições positivas mantidas na certificação Fast-Infra.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); objetivo específico 202. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas;

208. Garantir segurança energética, com expansão das fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

- 03: Promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares;

Resultados associados: Redução da percentagem de partos por cesária no HRMS – Indicador de gênero; Aumento na percentagem de mulheres em posição de Conselho de Administração – Indicador de gênero; Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 106: Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. 1.07: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência; 108: Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal.

- 04: Melhorar as condições econômico-financeiras na estruturação de garantias de PPPs, com mecanismo de garantia por instituição financeira de classificação AAA;

Resultados associados: Melhoria de condições econômico-financeiras na estruturação de garantias de PPPs.

Adequação ao PPA 2024-2027 do governo federal: objetivo específico 306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos.

Os indicadores do Programa serão monitorados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas EPE/MS, como compromisso desse Programa. Esses indicadores não refletem necessariamente os indicadores de desempenho do contrato de concessão.

1. 8. **Indicadores**

1. 8. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução da mortalidade institucional no HRMS

Descrição:
Descrição:

Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da mortalidade institucional no longo prazo.

Fórmula de cálculo:

(Número de óbitos após 24 horas/total de saídas) * 100

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo geral do Programa
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a mortalidade no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas nos estudos de ampliação e melhoria da infraestrutura hospitalar.

Relevante (R): O indicador é uma medida relevante para expressar a melhoria da infraestrutura e gestão – pilares importantes do atendimento médico de qualidade, com um impacto positivo na redução da mortalidade, alinhando-se com a área estratégica 102.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de base: 7,3 (2025)

Meta: 5 (2032, mantendo a média de 5 durante toda a concessão)

Fonte de Dado: Relatório Gerencial do HRMS, coletado mensalmente, reportado anualmente.

1. 8. 4. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Redução da taxa de mortalidade na Unidade Coronária Intensiva (UCO) no HRMS

Descrição:
Descrição:

Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da mortalidade devido a doenças coronárias de pacientes atendidos no HRMS.

Fórmula de cálculo:

(Número de óbitos/total de saídas - UCO) * 100.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo geral do Programa
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a mortalidade no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas nos estudos de ampliação e melhoria da infraestrutura hospitalar.

Relevante (R): O indicador é uma medida relevante para expressar a melhoria da infraestrutura e gestão – pilares importantes do atendimento médico de qualidade, com um impacto positivo na redução da mortalidade, alinhando-se com a área estratégica 102.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de base: 9,4% (janeiro/2025)

Meta: 6% (2032)

Fonte de Dado: Relatório Gerencial do HRMS, coletado mensalmente, reportado anualmente.

1. 8. 7. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Taxa de letalidade nas UTIs do HRMS

Descrição:
Descrição:

Espera-se que a melhora dos serviços e da infraestrutura impactará na redução da letalidade no hospital devido a infecções.

Fórmula de cálculo:

(no de óbitos por infecção/ no de notificações por infecção) *100

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo geral do Programa
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a letalidade no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas nos estudos de ampliação e melhoria da infraestrutura hospitalar.

Relevante (R): O indicador é uma medida relevante para expressar a melhoria da infraestrutura e gestão – pilares importantes do atendimento médico de qualidade, com um impacto positivo na redução da letalidade, alinhando-se com a área estratégica 102.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de base: 47,6% (jan/2025)

Meta: 20% (2032).

Fonte de Dado: Relatório Gerencial do HRMS, coletado mensalmente, reportado anualmente

1. 8. 10. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS

Descrição:
Descrição:

A expansão do hospital aumentará o número de leitos disponíveis de 362 para 577 até o ano de 2032.

Fórmula de cálculo:

Valor absoluto de leitos disponíveis

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 1 (O1) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente os leitos disponíveis no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas na ampliação da capacidade do hospital, como compromisso da PPP.

Relevante (R): O indicador mede diretamente o objetivo de aumento dos leitos disponíveis no HRMS, sendo relevante não só para medir o objetivo específico 1, mas também um dos indicadores que medem a ampliação do acesso da população à saúde pública de qualidade.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de Base: 362 (2024)

Meta: 577 (2032)

Fonte de dado: Relatório de monitoramento do desempenho da concessão emitido pelo Verificador Independente.

1. 8. 13. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Aumento do atendimento anual no HRMS

Descrição:
Descrição:

Esse indicador reflete a expansão do número de leitos e, consequentemente, o aumento do número de pacientes atendidos anualmente no HRMS.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 1 (01) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente o aumento do atendimento anual no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas na ampliação da capacidade do hospital, como compromisso da PPP.

Relevante (R): O indicador é resultado direto da ampliação da capacidade do hospital, sendo relevante não só para medir o objetivo específico 1, mas também um dos indicadores que medem a ampliação do acesso da população à saúde pública de qualidade.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2030, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de base: 16.800 internações/ano

Meta: 33.120 internações/ano (2030)

Fonte de Dados: Relatório emitido pela gestão do hospital, com dados consolidados da Secretaria da Saúde.

1. 8. 16. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Taxa de ocupação do Pronto Atendimento

Descrição:
Descrição:

Esse indicador reflete redução da taxa de ocupação, devido à expansão dos leitos e do melhor atendimento.

Fórmula de cálculo:

(número de pacientes-dia/número de leitos-dia) * 100.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 1 (O1) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a taxa de ocupação do Pronto Atendimento no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas na ampliação da capacidade do hospital, como compromisso da PPP.

Relevante (R): O indicador mede a qualidade do atendimento devido à ampliação da capacidade do hospital e dos equipamentos novos, sendo relevante não só para medir o objetivo específico 1, mas também um dos indicadores que medem a ampliação do acesso da população à saúde pública de qualidade.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de base: 188% (jan/2025)

Meta: 90% (jan de 2032, mas será monitorado mensalmente).

Fonte de dado: Relatório de monitoramento do desempenho da concessão emitido pelo Verificador Independente.

1. 8. 19. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Aumento da rotatividade de pacientes

Descrição:
Descrição:

Esse indicador reflete a melhora operacional do hospital, caracterizado pelas atividades desenvolvidas pela equipe de gestão de alta, trabalhando ativamente no processo de desospitalização do paciente.

Fórmula de cálculo:

Total de saídas/número de leitos.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 2 (O2) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a taxa de rotatividade dos pacientes no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas na ampliação da capacidade do hospital e melhoras na gestão hospitalar, como compromisso da PPP.

Relevante (R): Este indicador é relevante pois a liberação do paciente está associada com um atendimento de qualidade em uma infraestrutura nova, governado por uma melhora operacional do hospital, que trabalham ativamente no processo de desospitalização do paciente. Reflete não só a melhora operacional do hospital (O2), mas também mede a ampliação do acesso a serviço de qualidade pelo SUS à população beneficiada.

Temporal (T): O ano de monitoramento é anual, com meta de redução em 2032, e manutenção até o fim da concessão.

Meta:
Linha de Base: 3.7 (2024)

Meta: 4 (2032, medidos anualmente)

Fonte de dado: Relatório de monitoramento do desempenho da concessão emitido pelo Verificador Independente.

1. 8. 22. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS

Descrição:

Descrição:

A melhoria da infraestrutura hospitalar aumentará a satisfação de pacientes em relação a qualidade do atendimento.

Fórmula de cálculo:

(Número total avaliações positivas (Bom e Ótimo) /número total de entrevistados) * 100.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 2 (O2) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 102.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas na ambição de prestar um serviço de qualidade, com a melhora da infraestrutura e da gestão operacional do hospital.

Relevante (R): Este indicador é relevante pois expressa a satisfação dos usuários, com o serviço de qualidade do SUS prestado pelo HRMS.

Temporal (T): O indicador será coletado a cada ano, de acordo ao contrato da concessão, por meio de pesquisa e entrevistas que serão realizadas aos pacientes, com uma amostra representativa de pacientes e acompanhantes.

Meta:
Linha de Base: 70,4% (janeiro, 2024)

Meta: acima de 90% (a cada ano, a partir do ano 2030)

Fonte de dado: Relatório de monitoramento do desempenho da concessão emitido pelo Verificador Independente.

1. 8. 25. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Número de contribuições positivas adequadas ao selo Fast Infra

Descrição:
Descrição:

O selo FAST-Infra certifica projetos de infraestrutura que atendem altos padrões de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). Visa atrair investimentos privados, garantindo que os projetos contribuam para metas climáticas e desenvolvimento sustentável. O selo oferece transparência e confiança para investidores e financiadores. Assim, promove infraestrutura resiliente, verde e alinhada a compromissos globais de sustentabilidade.

A certificação com esse selo expressa a melhora da eficiência do hospital, considerando todos os aspectos de ESG. O Hospital já cumpriu a fase de self-assessment e obteve o selo internacional de certificação FAST-Infra Sustainable Infrastructure Label (FAST-Infra Label) na modalidade Autoavaliação, sendo a primeira no setor de saúde e terceiro projeto no Brasil, com as seguintes contribuições positivas:

- Mitigação das Mudanças Climáticas;
- Recursos e Economia Circular;
- Prevenção da Poluição;
- Inclusão e Gênero;
- Saúde e Segurança.

O selo internacional identifica projetos de infraestrutura sustentável, com o objetivo de facilitar o acesso desses projetos a financiamento privado e garantir sua credibilidade junto a investidores. Foi lançado em 2020 como uma iniciativa multissetorial, liderada por atores como o Banco Mundial (IFC), OCDE e a Climate Policy Initiative. O selo é concedido a projetos que atendem a um conjunto de padrões robustos e transparentes.

Fórmula de cálculo:

Número de contribuições positivas enquadradas

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 2 (O2) do Programa.

- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com as áreas estratégicas 202 e 208.

Requisitos SMART:

Específico (S): O FAST-Infra é uma certificação que mede o atendimento aos altos padrões de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). Portanto, se trata de uma medida já definida.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado anualmente.

Alcançável (A): Atualmente, o hospital já se adequa a 5 contribuições positivas, a meta é, no mínimo, manter essas contribuições.

Relevante (R): Este indicador é relevante pois é um proxy direto da melhoria da eficiência do hospital, com sustentabilidade, como mencionado no objetivo 2. É relevante às áreas estratégicas 202 e 208, pois é uma resposta à mitigação e redução de emissões nos negócios do hospital.

Temporal (T): O indicador será verificado pelo próprio HRMS, por meio de formulário aplicado anualmente.

Meta:
Linha de base: 5 (2025)

Meta: 5 (anualmente até 2056)

Fonte de dado: Formulário self-assessment da certificação FAST-Infra.

1. 8. 33. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Redução da percentagem de partos por cesárea no HRMS – Indicador de gênero

Descrição:
Descrição:

Este indicador reflete o melhor atendimento da mulher, com alternativas de partos mais humanizados, que não envolvam cesária.

Fórmula de cálculo:

(Número de partos cesária/número total de partos) * 100

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 3 (03) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 107.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a redução de cesárias no HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): Projeta-se baseado nas atividades de treinamento e conscientização.

Relevante (R): Uma maior conscientização dos envolvidos, dos médicos às parturientes, pode levar à redução no uso das cirurgias cesarianas para nascimentos, expressando um dos pilares importantes na melhora do atendimento à mulher, relativo ao Objetivo Específico 3 (03), e que também se alinha ao reforço da política de proteção e atenção às mulheres.

Temporal (T): O indicador será avaliado anualmente, com meta a partir de 2032.

Meta:
Linha de base: 65% (janeiro/2025)

Meta: 50% (2032, mas monitorado a cada ano)

Fonte de dado: Relatório de monitoramento do desempenho da concessão emitido pelo Verificador Independente.

1. 8. 36. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Aumento na percentagem de mulheres em posição de Conselho de Administração – Indicador de gênero

Descrição:
Descrição:

O concessionário terá que cumprir uma meta de 40% mínimo de mulheres no Conselho de Administração. Este indicador reflete a promoção de políticas de participação da mulher nos processos decisórios da gestão hospitalar.

Fórmula de cálculo:

(número total de mulheres em conselho da administração/ número total de pessoas no conselho de administração)

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 3 (O3) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 107.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a porcentagem das mulheres em posição de Conselho de Administração do HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado mensalmente.

Alcançável (A): Baseia-se no requerimento contratual de ter no mínimo 40% de mulheres no conselho de administração do hospital.

Relevante (R): Uma maior participação das mulheres no conselho de administração pode apoiar a políticas mais orientadas ao melhor atendimento à mulher e, junto com o Indicador 10, são relevantes para medir o melhor atendimento à mulher no HRMS e colaborar com o reforço das políticas de proteção e atenção à mulher.

Temporal (T): O indicador será avaliado anualmente, com meta a partir de 2032.

Meta:
Linha de base: 0

Meta: 40% (2032)

Fonte de dado: Relatório Gerencial do HRMS

1. 8. 39. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão

Descrição:
Descrição:

O concessionário terá como compromisso aumentar a participação de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e ampliar os colaboradores que se consideram transexuais. Este indicador reflete a inclusão de setores desfavorecidos no mercado da gestão hospitalar. Serão respeitadas as qualificações exigidas e as diretrizes de não discriminação.

Fórmula de cálculo:

Número total de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/número total de colaboradores;

Número total de colaboradores que se autodeclaram transsexuais/número total de colaboradores.

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 3 (03) do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a áreas estratégicas 106 e 109.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a porcentagem de colaboradores e colaboradoras que se autodeclaram de grupos minoritários do total dos colaboradores do hospital.
Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado anualmente.

Alcançável (A): Baseia-se no requerimento contratual de ter no mínimo 20% de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas e quilombolas; e 3% transsexuais.

Relevante (R): O indicador é relevante para medir a maior participação de grupos minoritários nos negócios do hospital, promovendo a igualdade racial e os direitos humanos como instrumento de inclusão social.

Temporal (T): O indicador será avaliado anualmente, com meta a partir de 2032.

Meta:
Linha de base: 0

Meta (pretas, pardas, indígenas e quilombolas): 20% (2032)

Meta (transexual): 3% (2032)

Fonte de dado: Relatório Gerencial do HRMS

1. 8. 42. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Melhoria de condições econômico-financeiras na estruturação de garantias de PPPs.

Descrição:
Descrição:

Esse indicador visa apresentar a redução de custos econômico-financeiros para o Estado, decorrente da substituição da garantia, de conta garantia (conforme utilizada nos contratos de PPPs atualmente contratados) para operação de crédito contingente. A manutenção do mecanismo de garantia na forma atualmente utilizada para as PPPs contratadas pelo Estado implica imobilização de recursos orçamentários em conta garantia. Esses recursos geram receitas mediante aplicação financeira BB Renda Fixa CP Automático Setor Público FICFIF. Entretanto, os recursos orçamentários não podem ser aplicados em políticas públicas, gerando um custo econômico. No caso da PPP HRMS, esse indicador visa comparar dois componentes de custos, em termos reais (descontado o componente de inflação pelo IPCA). Primeiro, o custo oportunidade da imobilização, em conta garantia, de recursos equivalentes à cobertura da operação de crédito contingente, representado pela taxa social de desconto de 8,5% ao ano (Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício de Projetos de Investimento em Infraestrutura e Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME), deduzido das receitas de aplicação financeira do mesmo montante. Segundo o custo estimado anual da disponibilização da cobertura de garantias mediante a operação de crédito contingente, conforme condições financeiras apresentadas no presente pleito. Do comparativo entre os dois custos resulta a economicidade econômico-financeira da solução proposta (operação de crédito contingente).

Fórmulas de cálculo:

CG*(TSD-RF): custo econômico-financeiro da cobertura de garantia, pelas condições atuais

CG*TG: custo econômico-financeiro da cobertura de garantia, pelas condições da operação de crédito contingente

Onde:

CG: Cobertura da Garantia de operação contingente, em R$

TSD: Taxa de desconto social, em termos reais, conforme Guia de Análise Custo-Benefício

RF: Remuneração anual da aplicação financeira BB Renda Fixa CP Automático Setor Público FICFIF, em termos reais (efeitos inflacionários IPCA implícitos)

TG: Taxa de garantia da operação de crédito contingente BID

Alinhamento:

- Objetivos do Programa: Este indicador está alinhado com o objetivo específico 4 do Programa.
- Área Estratégica do PPA 2024-2027: Está alinhada com a área estratégica 306.

Requisitos SMART:

Específico (S): O indicador mede especificamente a economicidade, em termos econômico-financeiros, da contratação da operação de crédito contingente para garantia da PPP do HRMS.

Mensurável (M): Fórmula de cálculo bem definida, com indicador coletado anualmente.

Alcançável (A): As projeções foram baseadas nas condições econômico-financeiras aplicáveis aos contratos de PPP atualmente contratados, às condições financeiras da operação de crédito contingente e a análise de custo-benefício aplicáveis a projetos de infraestrutura.

Relevante (R): O indicador é relevante para comparar a relação custo-benefício do atual mecanismo de garantia de PPPs oferecido pelo Estado (conta garantia), com a solução de operação de crédito contingente.

Temporal (T): O indicador será avaliado anualmente, com meta a partir do ano de contratação da operação de crédito contingente.

Meta:
Linha de Base: R$ 25 milhões/ano (2026), correspondente ao montante de cobertura de garantia de USD 80 milhões imobilizada (R$ 436 milhões) em conta garantia, submetida a uma taxa social de desconto de 8,5% a.a e aplicada a 2,62% a.a em termos reais (remuneração BB Renda Fixa CP Automático Setor Público FICFIF em 2024, líquido de IPCA e IR).

Meta: Redução de custos econômico-financeiros de R$ 21,5 milhões/ano a partir de 2027, correspondentes à diferença entre os custos anuais na linha de base (R$ 25 milhões) e custos anuais após contratação da operação de crédito contingente (R$3,5 milhões). Os custos da operação contingente foram calculados pelo montante da cobertura de garantia de USD 80 milhões (R$ 436 milhões), submetida a taxa de garantia da operação de crédito contingente do BID.

Fonte de dado: Taxa social de desconto: Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício de Projetos de Investimento em Infraestrutura e Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME

Aplicação financeira: Demonstrativos financeiros BB Renda Fixa CP Automático Setor Público FICFIF
Taxa de garantia da operação contingente: conforme condições financeiras do pleito.

1. 9. **Componentes**

1. 9. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Garantia às obrigações contratuais do Estado
Valor estimado em Dólar (USD): 80.000.000,00

Descrição:
Os recursos do programa serão integralmente utilizados para assegurar contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado, conforme previsto na Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, adequando-se ao sublimite específico para operações de crédito destinadas às parcerias público-privadas (PPP).

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto - Garantia às obrigações contratuais do Estado

O instrumento de garantia (operação de crédito contingente) desta Carta Consulta será crucial para viabilizar o projeto de PPP e impulsionar os investimentos do parceiro privado em uma ampla gama de componentes. Esta garantia (operação de crédito contingente) não financiará diretamente componentes específicos.

As garantias de pagamento (operação de crédito contingente), por sua vez, são instrumentos destinados a cobrir o descumprimento de obrigações de pagamento pelo governo (poder concedente). Essas obrigações, neste caso em concreto, abarcam o pagamento de contraprestações públicas que irão amortizar os investimentos privados em CAPEX e remunerar o OPEX no âmbito do contrato de concessão (Anexo 2 – Caderno de Encargos).

Investimentos planejados em CAPEX:

- Áreas de apoio compartilhadas (ex. Almoxarifado, farmácia, cozinha);
- Reforma do prédio atual e construção de um edifício novo, com possível expansão futura (estimativa de área 100 m2 por leito) - aumento de leitos e 362 para 577, incluindo nova área de radioterapia e day clinic (cirurgia geral, urologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, otorrinolaringologia, onco-ortopedia);
- Incorporação de transporte pneumático para trânsito de amostras de sangue e medicamentos;
  Aquisição de mobiliários, e equipamentos pela Concessionária;
- Novo bloco deve conter áreas tecnológicas (bloco cirúrgico, UTI, diagnóstico por imagem, etc);
- Pronto socorro permanece no prédio atual com ampliação de leitos de retaguarda.

Gastos de OPEX:

- Gastos Operacionais para Gestão e Direção do Hospital;
- Desenho e Plano Anual de Educação Continuada (PEC);
- Fornecimento de uniformes;
- Implementação dos Planos de Emergência e Contingência, Gestão Sustentável, Operação Assistida;
- Manual de Procedimentos Operacionais (MPO);
- Limpeza Hospitalar;
- Equipamentos de limpeza e de proteção hospitalar;
- Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos;
- Manutenção e Conservação de Jardins;
- Controle de Pragas;
- Recepção, Portaria e Vigilância;
- Estacionamento;
- Serviços de Segurança e Vigilância;
- Serviços de Arquivo Médico e Estatística (SAME) e Faturamento, incluindo o Prontuário Eletrônico;
- Transporte de Pacientes (Interno e Externo) e Administrativo;
- Operação e Manutenção das áreas de Necrotério;
- Lavanderia e Rouperia;
- Logística Hospitalar, incluindo farmácia;
- Central de Material Esterilizado;
- Nutrição e Dietética;
- Engenharia Clínica;
- Manutenção Predial;
- Serviço de Atenção Domiciliar;
- Insumos Hospitalares;
- Gases Medicinais;
- Gestão e Fornecimento de utilidades: água, esgoto, energia, elétrica, gás de cozinha, internet e telefonia;
- Tecnologia de informação e comunicação (TIC);
- Plano de Transição e Faseamento;
- Certificação.

1. 10. **Beneficiários**

Os beneficiários do projeto são de cerca de 1,5 milhões de pessoas, localizados na área de alcance do hospital - macrorregião de Campo Grande.

Especificamente, o hospital pretende alcançar atendimento de 132.000 ano, sendo 30.000 em internação, 42.000 em pronto-socorro, e 60.000 em ambulatório. Em relação ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), há duas equipes multiprofissionais que realizam cerca de 480 visitas domiciliares/mês. São cerca de 70 pacientes inscritos no programa, sendo que a meta do hospital é chegar a 100 pacientes acompanhados em domicílio.

1. 11. **Anexos**

1c. PPP HRMS - Caderno de TIC

1a. Estudo de Demanda e Programa de Necessidades

1b. PPP HRMS - Caderno de Encargos

1d. Nota Técnica Taxa Social

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Como a operação se trata de uma operação de crédito contingente, não há produtos associados às áreas estratégicas e aos resultados do Programa. Entretanto, entende-se que a viabilização da concessão, pela segurança oferecida pelo estado do Mato Grosso do Sul e pela garantia do BID, alavancará recursos privados que contribuirão para gerar investimentos que colaboram às áreas estratégicas mencionadas. A operação de crédito contingente também impacta para que os investimentos sejam realizados, sem sua paralisação, sendo então acionada quando necessário.

102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse alinhamento se evidencia na proposta de modernização da infraestrutura hospitalar, que visa aprimorar a gestão e a operação do hospital, ampliando o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. O projeto prevê o aumento do número de leitos de 362 para 577, a expansão da capacidade de atendimento para 132 mil procedimentos anuais, além do fortalecimento de diversas especialidades médicas que hoje operam com taxas de ocupação superiores a 90%, e da ampliação do Programa de Serviço de Atenção Domiciliar.

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se pelos objetivos estratégicos 1 e 2 do Programa, que expressam a ampliação do acesso da população à saúde pública de qualidade.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 1. Redução da mortalidade institucional no HRMS; 2. Redução da taxa de mortalidade na UCO do HRMS; 3. redução da taxa de letalidade nas UTIs do HRMS; 4. aumento da rotatividade de pacientes; 5. Aumento da satisfação de pacientes e acompanhantes do HRMS; 6. Aumento de leitos hospitalares na macrorregião de saúde de Campo Grande/MS; 7. Aumento do atendimento ano no HRMS; 8. Taxa de ocupação do Pronto Atendimento.

Replicação e inovação: As PPPs de infraestrutura social ainda não são comuns no Brasil, mas tem ganhado cada vez mais relevância. Esse projeto, atado com um mecanismo de crédito contingente (garantia) para dar maior segurança ao setor privado, tem a capacidade de ser replicado não só para outros estados, mas também para hospitais em mãos do governo federal.

106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. O concessionário deverá promover políticas para inclusão de populações desfavorecidas (parda, preta, quilombola, indígena e transexuais) no quadro de colaboradores do hospital, com uma porcentagem mínima, estabelecida no indicador. Ampliando a diversidade no quadro de colaboradores impacta em um melhor atendimento a essas populações.

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se pelo objetivo estratégico 3 do Programa, que busca promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 12. Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão.

Replicação e inovação: A promoção de políticas de inclusão social de grupos minoritários vítimas de injustiças via a exigência de quotas para esses grupos em contrato de concessão é uma inovação contratual em PPPs no Brasil recentemente. Essa requisição pode servir como benchmarking para outras iniciativas de PPP em infraestrutura social.

107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. As atividades relacionadas serão: (i) melhora da infraestrutura da maternidade e maior conscientização dos envolvidos para redução das cesárias; (ii) obrigação do concessionário de colocar no conselho da administração pelo menos 40% de mulheres, dando maior voz às mulheres no poder decisório da gestão do hospital.

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se em seu objetivo específico 3: Promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 10. Redução da percentagem de partos por cesária no HRMS – Indicador de gênero; 11. Aumento na percentagem de mulheres em posição de Conselho de Administração.

Replicação e inovação: Políticas afirmativas, principalmente na parte de gestão do hospital – conselho administrativo, podem contribuir para melhorar as políticas de atenção às mulheres nos hospitais principalmente de alta complexidade. Esses requerimentos via contratual é um mecanismo inovador no Brasil, e tem alto poder de replicabilidade em outras PPPs sociais semelhantes.

109. Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal. As atividades de obrigação contratual para quotas às pessoas de grupos minoritários, principalmente negras, pardas e quilombolas têm um impacto na promoção da igualdade racial de modo estruturante e transversal.

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se pelo objetivo estratégico 3 do Programa, que busca promover a inclusão e as políticas voltadas à mulher e populações desfavorecidas no atendimento e nos serviços hospitalares.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 12. Aumento na percentagem de colaboradores que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas ou quilombolas/ e transexuais – Indicador de inclusão.

Replicação e inovação: A promoção de políticas de inclusão social de grupos minoritários vítimas de injustiças via a exigência de quotas para esses grupos em contrato de concessão é uma inovação contratual em PPPs no Brasil recentemente. Essa requisição pode servir como benchmarking para outras iniciativas de PPP em infraestrutura social.

202. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas. A adequação a esse objetivo se dá por meio do fortalecimento da operação hospitalar, com foco na eficiência das áreas de apoio à assistência clínica, na adoção de tecnologia de ponta e em processos sustentáveis. A concessão contempla diversas iniciativas alinhadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, destacando-se: (i) Economia circular e eficiência de recursos: tratamento seguro de cerca de 438 toneladas de resíduos Classe A por ano, reduzindo em 146 toneladas o volume encaminhado a aterros sanitários, promovendo a descaracterização dos resíduos infectantes e sua conversão em resíduos comuns (será dedicado 1% do CAPEX a esse sistema, e 1,5% da receita anual para a operação); (ii) Prevenção e controle da poluição: gestão de licenças e condicionantes; gestão de resíduos (excluindo coleta); monitoramento da qualidade da água; tratamento de efluentes; controle de vetores e pragas; treinamentos e auditorias ambientais, além de ações de educação ambiental e comunicação social (OPEX anual esperado de R$ 510 mil para essas atividades). Preveem-se também a possibilidade da verificação independente para a certificação da FAST Infra, selo de ESG (ver Anexo).

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se em seu objetivo específico 2.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 9. Número de contribuições positivas adequadas ao selo Fast Infra
Replicação e inovação: A iniciativa pode ser replicada em outras unidades hospitalares no Brasil, promovendo uma padronização de práticas sustentáveis na gestão hospitalar. A adoção de tecnologias ambientais inovadoras, como o sistema de descaracterização de resíduos infectantes, representa um avanço significativo no setor e pode impulsionar a inovação em políticas públicas de saúde e meio ambiente. Além disso, o uso do selo FAST Infra como referência em certificação ESG reforça a possibilidade de atração de investimentos sustentáveis em outros projetos do país.

208. Garantir segurança energética, com expansão das fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética. A adequação a esse objetivo se dá por meio da melhora da eficiência energética e no aumento do uso de energia renovável. Espera-se implantar sistemas em que 20% da energia seja renovável (9,2 milhões de investimento do CAPEX), além de programas de eficiência energética e sustentabilidade. Prevê-se também a possibilidade da verificação independente para a certificação da FAST Infra, selo de ESG (ver Anexo).

306. Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos. A operação de crédito contingente do BID permitirá que os recursos aplicados na conta garantia sejam utilizados para outros propósitos da administração pública, levando à melhor aplicação dos recursos públicos, com responsabilidade. A garantia também é essencial para atrair o setor privado para a PPP de infraestrutura social, ampliando o investimento privado na área de infraestrutura social.

Adequação ao objetivo específico: Adequa-se em seu objetivo específico 2.

Adequação pelo Indicador da Matriz de Resultado: 13. Melhoria de condições econômico-financeiras na estruturação de garantias de PPPs. O indicador reflete, primeiramente, em sua linha de base, o custo de oportunidade de não usar esse recurso em outras políticas públicas vis-à-vis os recursos da operação de crédito contingente do BID.

Replicação e inovação: O modelo proposto pode ser replicado em outros estados e municípios interessados em viabilizar PPPs de infraestrutura social, utilizando operações de crédito contingente como instrumento para otimizar o uso de garantias públicas. Essa abordagem reduz o custo de oportunidade e libera recursos para outras áreas prioritárias, mantendo a responsabilidade fiscal. No campo da inovação, destaca-se a aplicação integrada de mecanismos financeiros típicos de grandes projetos de infraestrutura econômica no setor de infraestrutura social, ampliando a atratividade para investidores privados. A possibilidade de estruturar garantias mais robustas e previsíveis, aliada ao uso de conta garantia com flexibilidade de destinação, configura uma solução inovadora que combina segurança jurídica, sustentabilidade fiscal e estímulo ao investimento privado.

O pleito se adequa a uma prioridade da administração pública:

Eixo V – novo Plano de Aceleração do Crescimento. Em 17 de outubro de 2024, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul encaminhou ao Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 9498/2024/SES (anexo), solicitação de manifestação quanto à viabilidade de realocação dos recursos vinculados ao Termo de Compromisso nº 963347/2024/MS/CAIXA, com vistas à destinação como aporte público no âmbito do referido projeto de PPP. Tais recursos, no valor de R$ 152,9 milhões, foram originalmente aprovados no Novo PAC Seleções 2023 para a implantação de uma maternidade de porte II e aquisição de equipamentos. Contudo, a modelagem adotada no projeto de PPP do HRMS já contempla infraestrutura dedicada à linha materno-infantil, com 148 leitos, 5 salas de pré-parto, parto e pós-parto e outras instalações específicas, o que torna a destinação desses recursos à parceria uma solução mais eficiente, sem a perda da finalidade da linha assistida pelo PAC e com elevado potencial de antecipação de benefícios à sociedade. Para completar esse passo, tramita sob o número de processo 00130.000149/2024-99 a edição de ato normativo conjunto do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministério da Fazenda e

da Controladoria-Geral da União, em coordenação com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias em Investimentos da Casa Civil, para disciplinar o modelo de repasse de recursos federais a projetos dessa natureza.

2. 2. **Anexos**

2a. Oficio N. 9498-2024-SES

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A estruturação da concessão foi feita pelo Escritório de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Estado de Governo. O executor da Concessão Administrativa dos Serviços Não Assistenciais do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul (HRMS) é a concessionária vencedora do edital de licitação. A Secretária de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul fará a supervisão do contrato de concessão.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Escritório de Parcerias Estratégicas EPE/MS
Órgãos parceiros:
Fundação Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul (FUNSAU)
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS)
Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul (FESA)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O projeto será executado pelo consórcio vencedor da licitação de concessão, escolhido pela sua capacidade técnica e financeira. A Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES-MS) acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços e compromissos do contrato, com apoio do verificador independente.

Não haverá a conformação de uma Unidade de Gerenciamento do Programa dentro do estado, já que o projeto será executado pelo concessionário vencedor da licitação. A SES-MS já possui uma estrutura adequada para a supervisão do contrato de concessão.

Da mesma forma, o BID, para aprovação do projeto, exige a realização de uma análise da capacidade institucional, utilizando a metodologia PACI (Plataforma de Análise da Capacidade Institucional), com o objetivo de identificar possíveis fragilidades no processo de supervisão da SES-MS. Como é um projeto financiado pelo BID via mecanismo de garantia, espera-se apoio técnico e capacitação das instituições envolvidas em monitoramento e gestão de contratos em concessões, melhorando os procedimentos vigentes. Essa capacitação será fornecida pelo BID, de acordo com seus próprios recursos disponíveis.

O BID exige um Manual Operativo detalhando as instituições envolvidas e suas responsabilidades. Os órgãos executores possuem atribuições e funções específicas no Programa:

Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado: integrante da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica conforme a Lei nº 5.829/2022, foi responsável pela estruturação da concessão administrativa do HRMS, contando com o apoio da FUNSAU e da SES/MS.

Fundação Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul (FUNSAU): fundação gestora do HRMS e, no âmbito da PPP, gerenciará o quadro de recursos humanos referente à “bata branca” do hospital. Além disso, apoiará a SES na supervisão do contrato e fiscalização do cumprimento das metas pactuadas. Participará dos Comitês Técnico de Governança, de Interface e de Insumos Hospitalares.

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS): Órgão responsável por coordenar as políticas públicas de saúde no estado, com foco na regionalização e qualidade dos serviços. A SES/MS é o poder concedente da PPP, encarregada da licitação e contratação do projeto, e assume as responsabilidades de supervisão e fiscalização do contrato, garantindo o cumprimento das metas e indicadores.

Parceiro Privado (Concessionária): A empresa vencedora da licitação será responsável pelo investimento, gestão, operação e manutenção do HRMS. Participará dos Comitês Técnico de Governança, de Interface e de Insumos Hospitalares, atuando na execução dos serviços conforme o contrato.

Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul (FESA): Fundo público de natureza orçamentária, financeira e contábil que cobre as obrigações financeiras do Governo do Estado em relação à PPP. Por meio do FESA, são garantidos os recursos vinculados para pagamento à Concessionária, conforme autorizações legais específicas.

Garantias: Os recursos destinados à PPP são transferidos do Fundo de Participação dos Estados (FPE), até limites previstos em lei, para uma conta vinculada que remunera mensalmente a Concessionária com 130% da contraprestação pública. O saldo restante é destinado a uma escrow account (conta garantia), equivalente a uma contraprestação pública mensal, para garantir o adimplemento do poder público.

Agente Depositário (Banco do Brasil): Instituição financeira responsável pela movimentação exclusiva dos recursos vinculados ao contrato da PPP, operando mediante contrato próprio.

Verificador Independente: Pessoa jurídica contratada pela Concessionária para monitorar e aferir o desempenho dos serviços, auxiliando o Poder Concedente na fiscalização das obras, investimentos e serviços. Atua com imparcialidade e independência, definindo a contraprestação pública mensal efetiva após aplicar eventuais penalidades decorrentes da avaliação do desempenho.

Comitês da PPP

Comitê Técnico de Interface: Composto por representantes da Concessionária, do Poder Concedente e do corpo clínico do hospital, tem o objetivo de estabelecer procedimentos operacionais do dia a dia do hospital, evitando falhas na comunicação e conflitos entre as equipes “bata branca” (FUNSAU) e “bata cinza” (Concessionária).

Comitê de Insumos Hospitalares: Reúne representantes da Concessionária, do Poder Concedente e do corpo clínico para avaliar trimestralmente o consumo de insumos hospitalares, elaborar a lista referencial de aquisição, definir padrões de qualidade e preços.

Comitê Técnico de Governança: Destinado à resolução de divergências sobre a interpretação e cumprimento das obrigações contratuais, é composto pelo Poder Concedente, Concessionária e um terceiro independente eleito em comum acordo pelas partes.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

3b. Matriz de Responsabilidade - MS.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

Os investimentos necessários para o CAPEX e OPEX serão realizados pela concessionária, que ficará responsável, por contrato, em realizar a manutenção e operação do HRMS, durante o período de 30 anos de concessão. Espera-se que durante todo o período da concessão, os investimentos de CAPEX sejam de R$ 954 milhões e de operação, gestão e manutenção de R$ 6,8 bilhões ao longo de 30 anos. Os recursos virão das contraprestações realizadas pelo estado do Mato Grosso do Sul à concessionária, que serão garantidas pelo instrumento de pagamento contingente (garantia) em caso de inadimplência do estado do Mato Grosso do Sul. Os investimentos para operação, gestão e manutenção incluem todos os itens já mencionados na seção 1.5. Componentes.

Com o objetivo de garantir a integridade da infraestrutura implantada e a qualidade da prestação dos serviços para o período após o término de vigência da PPP, o contrato prevê salvaguardas nos últimos 5 anos da concessão, tais como o aumento dos valores de garantia de execução do contrato nos últimos 5 anos da concessão e a intensificação de reinvestimentos.

Para assegurar a perenidade dos ganhos de eficiência da PPP e incorporar seus benefícios ao cotidiano da administração estadual, desde a concepção do projeto foram implementadas diversas iniciativas de capacitação e integração dos servidores da saúde no contexto das Parcerias Público-Privadas. O Escritório de Parcerias Estratégicas mantém um programa de capacitação continuada para servidores públicos estaduais na temática de PPPs e Concessões, visando preparar as equipes para a gestão qualificada dos contratos. Como exemplo, em 2024 foi realizado treinamento, ministrado por técnicos da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil do Governo Federal, com foco em PPPs na área da saúde, que contou com a participação de 50 servidores da SES/MS. Dentro de um horizonte de 5 anos anteriores ao término do contrato de PPP (em 25 anos), o Estado avaliará o melhor modelo para continuidade da prestação de serviço adequada e eficiente, podendo manter a sistemática de PPPs ou inovações da época.

3. 3. Planejamento Estratégico

O Programa está plenamente alinhado com o Plano Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul 2024-2027, que estabelece como prioridade a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços de média e alta complexidade no estado. Entre as diretrizes do Plano, destacam-se o fortalecimento da rede hospitalar, a redução das desigualdades regionais na oferta de serviços e a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao investir na modernização da infraestrutura hospitalar, aquisição de equipamentos e capacitação das equipes, o projeto contribui diretamente para alcançar os objetivos estratégicos definidos no Plano Estadual de Saúde, incluindo a diminuição das filas de espera, a ampliação da capacidade de atendimento e o aumento da qualidade assistencial.

Além disso, a iniciativa está integrada ao PPA 2024-2027 do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que prevê investimentos em saúde como eixo prioritário para o desenvolvimento regional e para a melhoria da qualidade de vida da população. A modernização do HRMS visa não apenas atender à crescente demanda por serviços especializados, mas também fomentar a eficiência na gestão pública, reduzir custos a longo prazo e estimular o desenvolvimento socioeconômico local. Dessa forma, o projeto reafirma o compromisso do estado com uma saúde pública mais acessível, resolutiva e humanizada (Ver Anexo: Plano Estadual de Saúde 2024-2027).

3. 4. Anexos

3. Plano Estadual de Saúde 2024-2027

3a. PPPMS_Organograma estrutura operacional

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Riscos relativos à licitação deserta
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Atualmente, os instrumentos legais para o lançamento da licitação já foram validados após consultas públicas e audiências. O principal risco é que a licitação saia deserta, por falta de empresas interessadas ou empresas que não qualifiquem para esse processo licitatório. Este risco pode inviabilizar a implementação do projeto no prazo estipulado.

Prevenção e Mitigação:
Além das audiências públicas realizadas, o governo do estado do Mato Grosso do Sul realizou audiências com funcionários e especialistas da área de saúde, dando robustez ao projeto. A estruturação contou com o apoio do BID, que tem ampla experiência na região da América Latina e do Brasil em estruturações de concessões e parcerias público-privadas. Por fim, o estado realizou Road show do projeto entre os dias 24 e 25 de julho de 2025 com sessões bilaterais com empresas e financiadoras interessadas na licitação, com o objetivo de atrair mais licitantes para o projeto. A certificação Fast Infra obtida recentemente que permitirá que o projeto seja divulgado em eventos com investidores internacionais que propiciará uma ampliação dos potenciais licitantes para o projeto.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Riscos relativos a contratações para implementação do projeto e operação do hospital
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As contratações são realizadas pelo setor privado, havendo sempre risco do monitoramento do cumprimento do caderno de encargos da concessão.

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da concessão, podem gerar custos adicionais para o projeto.

Prevenção e Mitigação:
O próprio processo seletivo para escolha da empresa concessionária inclui critérios técnicos que atestam a experiência do concessionário na execução de atividades semelhantes às contratadas. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, incluída a elevação do custo de mão-de obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da concessão, podem gerar custos adicionais para o projeto. Sua alocação está direcionada para a concessionária, que é quem possui melhores condições de gerenciar o risco. Da mesma forma, a concessionária assume os riscos relacionados com a disponibilidade de serviços e fornecimentos necessários para a concessão.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco de baixa capacidade institucional de supervisão do contrato por parte da SES
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
É a primeira vez que o poder concedente (SES-MS) supervisará um contrato de concessão de hospitais no estado do Mato Grosso do Sul. Essa supervisão requer pessoal especializado não só do ponto de vista técnico, mas também de conhecimento de contratos de concessão e de PPPs. As debilidades de supervisão podem afetar o bom andamento da implementação dos investimentos necessários e qualidade do serviço prestado.

Prevenção e Mitigação:
O Estado do Mato Grosso do Sul capacitará os funcionários da SES-MS em concessões e parcerias público-privadas, com foco em supervisão dos contratos. Além disso, o contrato preverá a contratação do Verificador Independente, para monitorar e aferir o desempenho dos serviços deste Contrato, auxiliando o Poder Concedente no monitoramento e avaliação das Obras e Investimentos e serviços prestados pela Concessionária. A EPE já tem ampla experiência em gestão de contratos de concessões e PPPs já assinados, com um corpo técnico altamente qualificado que permitirá a transferência de conhecimento da gestão contratual para o contrato do hospital.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Inadimplência do setor público em relação às obrigações de pagamentos ao concessionário
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Por ser uma concessão administrativa, a concessionária depende das contraprestações que serão pagas para realizar os investimentos necessários, gerir, operar e manter a infraestrutura e os serviços do HRMS. Em cenários de contingência e restrição fiscal no futuro, há o risco de que o estado não transfira os recursos necessários para amortizar o CAPEX e remunerar o OPEX. Esse risco pode afetar com que se cumpram os indicadores de desempenho da concessão, comprometendo o atendimento do hospital.

Prevenção e Mitigação:
A operação de crédito de que trata o pleito está direcionada à garantia de pagamento contingente à concessionária em virtude da concretização de inadimplementos do poder concedente. Caso o Poder Concedente não realize o pagamento para a concessionária, a garantia (pagamento contingente) poderá ser acionada. O próprio instrumento utilizado servirá para mitigar esse risco, e dar maior segurança ao concessionário.

Além disso, o Estado de Mato Grosso do Sul oferece, nos contratos de PPPs, um mecanismo de dupla garantia, composto de vinculação de recursos orçamentários (FPE e Lei Complementar 176/2020, que são destinados para pagamento de obrigações contratuais das parcerias), e um colchão de liquidez (nas PPPs atualmente contratadas, formado por uma conta garantia, e na PPP HRMS, pela operação de crédito contingente). A vinculação de recursos orçamentários será mantida, mesmo com a contratação da operação de crédito contingente.

Para mitigar o risco de descasamento entre a vigência do contrato de PPP e o contrato da operação de crédito contingente, o mecanismo atual de garantias de PPPs, baseado em conta garantia, será utilizado para o contrato de PPP tanto em seu período inicial (entre a assinatura do contrato de PPP e a celebração do contrato da operação de crédito contingente) quanto em seu período final (após decorrido o prazo de 25 anos do contrato de operação de crédito contingente).

4. 5. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
0	300	300

Juros aplicáveis:
Não se aplica. Quando a garantia for contratada, haverá o pagamento anual de taxa pela garantia concedida, no valor de 0.8% ao ano. Em caso de acionamento da garantia (eventual inadimplência do PC), aa Taxa de juros vigente é de SOFR+1,20% a.a.
Periodicidade dos Pagamentos:
Não se aplica
Comissão de Compromisso:
Não se aplica
Comissão de Avaliação:
Não se aplica
Taxa de Abertura:
Não se aplica
Outros encargos:

Não se aplica

Outras Informações:

1. **Operacionalização**

I) Sobre a incidência da Comissão de Garantia:

Momento 01: Contratação da Garantia (Operação de Crédito Contingente)

- Descrição do momento: Valor a ser pago pelo Estado após assinatura do contrato com o BID, ou seja, pagamento pela disponibilidade da Garantia.
- Descrição da Taxa: **Comissão de Garantia**
- Valor: **0,8%** ao ano (Revisado anualmente), aplicados sobre o montante de garantia não acionada

Momento 02: Acionamento da Garantia

- Descrição do momento: Caso o estado não realize um dos pagamentos ao parceiro privado no contrato de concessão e a garantia seja acionada:
- A taxa do empréstimo será: SOFR: 4,28% + 1,20% (A+B) = 5,48%*
  - A) Margem de financiamento variável aplicável ao terceiro trimestre de 2025: 0,40% (Recalculada trimestralmente)
  - B) Margem do capital ordinário aplicável ao ano de 2025: 0,80% (Revisado anualmente)

O valor da garantia contratado é denominado montante máximo ou montante exigível da garantia, no caso deste pleito, o valor é de USD 80MM. Sobre o valor da garantia acionada incidirá a taxa do Momento 02 e a taxa do Momento 01 incidirá sobre o novo montante exigível da garantia, equivalente ao montante máximo subtraído do valor da garantia acionado.

[*] Valor variável. As taxas praticadas pelo BID podem ser consultadas no link a seguir: https://www.iadb.org/en/how-we-can-work-together/public-sector/financing-solutions/interest-rates-and-charges

II) Sobre os prazos para reembolso de montante da garantia desembolsados:

O prazo total da garantia é limitado a 25 anos.

Em caso de acionamento da garantia, o prazo para pagamento do Estado ao BID será equivalente ao prazo remanescente da vigência da garantia.

III) Sobre os prazos do contrato de PPP e da operação de crédito contingente

Haverá descasamento entre o prazo da concessão e a operação de crédito contingente. O contrato da operação de crédito depende de trâmites de análise e aprovação no BID, Ministério da Fazenda, Procuradoria da Fazenda Nacional e Senado Federal. Em decorrência do prazo necessário para essas etapas, a operação de crédito poderá ser celebrada com o contrato de concessão já em execução. Além disso, o prazo da operação de crédito (25 anos) é inferior ao prazo do contrato de concessão, havendo descasamento também no período final.

Para mitigar o risco de descasamento descrito acima, o mecanismo atual de garantias de PPPs, baseado em conta garantia, será utilizado para o contrato de PPP tanto em seu período inicial (até celebração do contrato da operação de crédito contingente) quanto em seu período final (após término da vigência do contrato de operação de crédito contingente). A vinculação de recursos orçamentários será mantida, independentemente da solução adotada para cobertura de eventos de inadimplência (conta garantia ou operação de crédito contingente). Nesse ponto, é importante ressaltar que o duplo mecanismo de garantia, formado pela vinculação de recursos orçamentários e pela conta garantia, funciona de modo adequado para as PPPs contratadas pelo Estado (Infovia Digital e Usinas Fotovoltaicas).

Poderá ainda, no longo prazo, ser sondada alternativa de mercado que atenda à transição de garantias no período final de contrato da PPP, como nova operação de crédito contingente, fundos garantidores públicos ou privados, etc.

2. Contexto de Mercado

Em face do significativo aumento da taxa de juros em nível de fontes internas, a partir de uma taxa referencial utilizada pelos agentes financeiros nacionais, com base na taxa referencial do CDI, o financiamento oriundo de fonte externa consiste ainda um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes de recursos internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à aplicação em reformas de políticas públicas pelos entes subnacionais, necessários à melhoria do acesso a serviços públicos de qualidade, indispensáveis ao pleno desenvolvimento sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul, razão por que o estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de suportar, considerando que as necessidades de recursos extrapolam em muito os recursos ordinários previstos no orçamento geral do estado para os exercícios.

Desta forma, objetivando a viabilização do projeto, o estado identificou opções de fontes de recursos externas, tendo como base as propostas identificadas no item - Condições Financeiras, apresentados por organismos financeiros no âmbito externo, considerando ser o Mato Grosso do Sul um ente subnacional que possui nota de capacidade de pagamento, classificada como rating "A+" que permite que o estado esteja elegível a receber a garantia da União para novos empréstimos.

Após a análise financeira, com base nas condições financeiras do BID e do Banco Mundial que oferecem a classificação de crédito AAA, o estado deliberou por escolher o BID, pelos seguintes motivos: (i) condições financeiras mais favoráveis do que a do Banco Mundial; (ii) o BID possui tradição no apoio a países da América Latina e Caribe, a possibilidade da utilização de sua garantia é a melhor opção à disposição do estado do Mato Grosso do Sul, pois o BID pode emitir garantias para mitigar uma variedade de riscos políticos ou de crédito associados a um projeto de desenvolvimento. A opção pelo uso de garantias do BID se justifica por sua reputação global, solidez financeira e vasta experiência em projetos de desenvolvimento em todo o mundo, além da classificação do crédito AAA, que transmite confiança aos investidores.

O BID tem sido referência na estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) na região da América Latina e no Caribe, por meio de sua unidade INE/PPP. Na região, o BID já viabilizou mais de USD 15 bilhões em investimentos. No Brasil, o banco participa da estruturação de 29 projetos, em diferentes fases de andamento, totalizando cerca de USD 12,1 bilhões, em setores estratégicos como transporte, energia, ativos ambientais, saneamento e saúde, comprovando sua expertise.

Combinando recursos próprios e de doadores, INE/PPP oferece assistência técnica em duas frentes principais:

- Fortalecimento Institucional: apoiando os países a implementar Concessões e PPPs que sejam socioeconomicamente rentáveis, fiscalmente responsáveis e sustentáveis. Este trabalho envolve reformas regulatórias, capacitação e a disseminação de conhecimentos práticos sobre modelos bem-sucedidos.
- Assessoria na Estruturação de Projetos: apoiando na elaboração de projetos que maximizem o uso de recursos públicos e sejam atrativos para o setor privado, equilibrando risco e retorno.

O BID é pioneiro no apoio tanto "a montante" (upstream), auxiliando na criação de quadros regulatórios e planejamento de infraestrutura, quanto "a jusante" (downstream), estruturando projetos específicos em setores econômicos e sociais.

Exemplos destacados de projetos de Infraestrutura Econômica, Social e Ambiental:

- Infraestrutura Econômica: Focada em setores como transporte, energia e saneamento. Um exemplo é o Trem Intermunicipal (TIC) entre São Paulo e Campinas, com um investimento estimado de USD 2,5 bilhões, que visa melhorar a mobilidade e a conectividade regional. Outro destaque é o projeto de Iluminação Pública de Nova Lima, que já foi adjudicado e estima mobilizar USD 15 milhões, promovendo maior eficiência energética e segurança pública na região.
- Infraestrutura Social: Inclui áreas como saúde, educação e gestão de resíduos. Em Saúde, o BID tem experiências no Brasil e América Latina. No Brasil, está atuando em um projeto no Rio Grande do Sul e desenvolveu um projeto em Santa Catarina. No Peru, atuou nos projetos de Piura, Chimbote e Instituto de Saúde de Niño San Borja. Em educação, um projeto de reforma de 200 escolas no Rio de Janeiro, reforma de 143 escolas em São Paulo e um projeto de construção de 40 novas escolas no Paraná. Em resíduos, o banco atuou na estruturação de Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e na estruturação do projeto do vale do Rio dos Sinos. Além disso, atua também no projeto de penitenciária em Santa Catarina.
- Infraestrutura Ambiental: Projetos de infraestrutura ambiental concentram-se em ativos naturais ou construídos que sustentam a conservação de ecossistemas, a proteção da biodiversidade e a regulação climática.

Por meio dessa atuação, o BID tem sido um parceiro estratégico para o desenvolvimento de infraestrutura, promovendo impactos positivos que equilibram o crescimento econômico e o bem-estar social no Brasil e em toda a região.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Garantia às obrigações contratuais do Estado					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7° ano		8° ano		9° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10° ano		11° ano		12° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13° ano		14° ano		15° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16° ano		17° ano		18° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19° ano		20° ano		21° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22° ano		23° ano		24° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25° ano					
Financiamento	Contrapartida				
80.000.000,00	0,00				

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Em 7 de novembro de 2023, o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi oficialmente incluído no Programa de Parcerias do Estado. Em janeiro de 2024, o Estado contratou o assessoramento técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o desenvolvimento do projeto. Os estudos técnico, econômico e jurídicos foram entregues no final de 2024, e o projeto foi posto em consulta pública até 01 de junho de 2025 e, neste momento, as contribuições são examinadas pelo Poder Público.

Consulta e Audiências Públicas do Edital de Licitação para PPP do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e seus anexos: A consulta pública do projeto, com o lançamento da primeira versão do pré-edital e seus anexos, foi realizada no período de 15 de abril a 01 de junho de 2025. Além disso, o Governo do Mato Grosso do Sul realizou uma audiência pública do projeto no formato virtual. O projeto também foi apresentado para o Conselho Estadual de Saúde, composto por usuários do SUS, trabalhadores da área da saúde e representação do governo. Por fim, foi realizada rodada de roadshow do projeto após a consulta pública, entre os dias 24 e 25 de julho de 2025, composta por uma apresentação geral do projeto, aberta ao público, e sessões de reuniões bilaterais com empresas e financiadoras interessadas na licitação, contando com massiva participação do mercado, com oito reuniões com grupos interessados.

Os anexos incluem respectivamente a Modelagem Econômico-Financeira do Programa, a Minuta de Edital e a Minuta do Contrato.

A PPP do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul obteve o selo internacional de certificação FAST-Infra Sustainable Infrastructure Label (FAST-Infra Label) na modalidade Autoavaliação, sendo a primeira no setor de saúde e terceiro projeto no Brasil, com as seguintes contribuições positivas:

- Mitigação das Mudanças Climáticas: O cálculo das emissões evitadas, estimadas em 122 tCO/ano, considera a meta do projeto de que 20% da energia do hospital seja de fontes renováveis;
- Recursos e Economia Circular: projeto demonstra avanços concretos em economia circular ao destinar ~1% do CAPEX total para a implantação do sistema de tratamento de resíduos por micro-ondas, e ~1,5% da receita anual para sua operação;
- Prevenção da Poluição: CAPEX de R$ 9,2 milhões para a implantação de sistemas de geração de energia renovável;
- Inclusão e Gênero: O projeto prevê a contratação de 23% de trabalhadores de grupos vulneráveis, impactando 644 pessoas, sendo 221 na fase de investimentos e 423 na operação;
- Saúde e Segurança: Estima-se 25% de aumento na eficiência operacional, reduzindo filas de espera. O projeto contempla 60% de aumento de capacidade na infraestrutura. Além disso, estima-se a redução do tempo de permanência de 7,1 para 5,3 dias e o aumento da rotatividade de 4 para 5,6 saídas/leito. Com isso, estima-se o seguinte número de atendimentos ano: 132,000 (Internação: 30.000, Pronto Socorro: 42.000, Ambulatório: 60.000).

O selo internacional identifica projetos de infraestrutura sustentável, com o objetivo de facilitar o acesso desses projetos a financiamento privado e garantir sua credibilidade junto a investidores. Foi lançado em 2020 como uma iniciativa multissetorial, liderada por atores como o Banco Mundial (IFC), OCDE e a Climate Policy Initiative. O selo é concedido a projetos que atendem a um conjunto de padrões robustos e transparentes.

6. 7. Anexos

6e. Certificação Fast-Infra Label

6c. PPP HRMS - Edital e Anexos

6f. Apresentação PAC HRMS

6a. Modelo Econômico-Financeiro

6b. Relatorio-de-Modelagem-Economico-Financeira

6d. PPP HRMS - Minuta de Contrato

6g. Aceite BID - Operacao de Credito

7. **Baixar todos os anexos**

Download